

	Mapa de Processos: BLOCO CIRÚRGICO	Código: tag_ds_codigo_end
	Dono do Processo: Coordenador(a) do Bloco Cirúrgico	Versão: tag_ds_versao_end
	Início do Processo: Admissão do paciente no bloco cirúrgico (eletivo via ambulatório ou urgência via PS/internação).	
	Fim do Processo: Transferência do paciente para o leito de internação ou permanência na SRPA até disponibilidade de vaga. Encerramento do procedimento, envio de materiais sujos à CME e atualização dos registros assistenciais e administrativos.	

FORNECEDORES	ENTRADA	PRINCIPAIS ATIVIDADES	PRODUTOS	CLIENTES
PS, Ambulatório, Internação, CTI	Pacientes agendados (eletivos) ou urgência/onda	1) Admissão do paciente e aplicação de pulseiras de risco assistencial 2) Preparação da sala cirúrgica (instrumentais, equipamentos, kits de medicação) 3) Realização do procedimento cirúrgico 4) Processamento de materiais 5) Pós-operatório imediato 6) Gestão de leitos: Solicitação e organização de vaga no leito (via NIR) 7) Transferência do paciente da SRPA para o leito de internação (ou permanência na SRPA até liberação)	Paciente estável	CTI, Unidades de Internação.
Farmácia	Kits de medicação, Equipamentos necessários, carrinho de medicamento, OPME		Procedimento cirúrgico realizado, Paciente pós-cirúrgico	Paciente, Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA)
CME	Material e equipamento estéril		Checklist de peças antes e pós cirurgia, Instrumentos utilizados com prime aplicado	CME
NIR	Reserva de leito pós-operatório Liberação de cirurgia		Solicitação de leito, agenda de cirurgias	NIR
Agência transfusional	Hemocomponente reservados ou emergenciais, resultados de tipagem sanguínea		Indicação de necessidade de limpeza	Higienização e Limpeza
Equipe de Higienização	Limpeza terminal da sala e reorganização para novo procedimento		Solicitação de hemocomponentes, aviso de cirurgia	Agência transfusional
Rouparia	Privativo, capote		Solicitação de abastecimento	Farmácia, Almoxarifado
Almoxarifado	Itens administrativos		Aviso de falecimento	Necrotério

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

- 1) **Admissão do paciente e aplicação de pulseiras de risco assistencial:** Quando o paciente chega ao bloco para cirurgia eletiva, urgência ou emergência, é realizado o acolhimento e conferência de dados, prontuário e pulseira de identificação. Em casos de emergência classificados como “onda”, um alarme externo é acionado, e se for de risco iminente, outro sinal toca dentro do bloco, liberando a entrada imediata. Pacientes são identificados com etiquetas e pulseiras que sinalizam riscos como queda, alergia e lesão por pressão. Esse processo garante segurança e rastreabilidade antes da entrada na sala. A conferência de exames, documentos e consentimento também faz parte da admissão.
- 2) **Preparação da sala cirúrgica (instrumentais, equipamentos, kits de medicação):** A equipe de enfermagem realiza a montagem da sala conforme o tipo de procedimento, separando instrumentais esterilizados, materiais, equipamentos e kits de medicação. A validade dos insumos e o funcionamento dos equipamentos são conferidos rigorosamente. A organização da sala é feita de forma específica para cada especialidade cirúrgica. Tudo é registrado para rastreabilidade e controle.
- 3) **Realização do procedimento cirúrgico:** O procedimento cirúrgico é executado pela equipe médica conforme o protocolo da especialidade e as condições clínicas do paciente. Durante toda a cirurgia, são monitorados sinais vitais, perfusão, sangramentos e intercorrências. Todos os materiais, medicamentos, órteses e próteses utilizados são conferidos e registrados. Ao término, inicia-se o fechamento cirúrgico e preparação para o pós-operatório.
- 4) **Processamento de materiais:** Após o procedimento, todos os materiais e instrumentais usados são direcionados para a área suja do bloco. A equipe da CME do bloco realiza a pré-lavagem, separando os itens e removendo resíduos orgânicos, garantindo os critérios de biossegurança. Depois dessa etapa, os materiais são encaminhados para a Central de Material Esterilizado (CME) para processamento completo. Esse fluxo garante que não haja risco biológico na reutilização. O rastreio dos materiais é feito por checklist.
- 5) **Pós-operatório imediato:** Finalizada a cirurgia, o paciente é encaminhado para a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), onde permanece em monitoramento intensivo. A equipe acompanha sinais vitais, dor, saturação, consciência e estabilidade hemodinâmica. Medicações como analgésicos, antieméticos e suporte ventilatório, se necessário, são administrados. O paciente aguarda na SRPA até alcançar critérios de alta para o leito de internação. Na ausência de vaga, permanece na SRPA sob monitoramento contínuo.
- 6) **Gestão de leitos:** Quando o paciente atinge critérios de alta da SRPA, a equipe do bloco solicita vaga junto ao Núcleo Interno de Regulação (NIR). O NIR verifica a disponibilidade nos setores de internação, como CTI, clínica cirúrgica ou enfermarias. Se não houver vaga imediata, o paciente permanece monitorado na SRPA até liberação. O controle do fluxo de leitos é essencial para liberar a sala cirúrgica e a própria SRPA para novos procedimentos. Esse processo é registrado no sistema.
- 7) **Transferência do paciente da SRPA para o leito de internação** (ou permanência na SRPA até liberação) Uma vez que o paciente recupera da anestesia e o NIR consegue alocar um leito, seja na clínica cirúrgica, clínica médica, CTI ou outras áreas, ele é então transferido para o seu leito definitivo.

8) Limpeza terminal da sala e reorganização para novo procedimento: Com a saída do paciente, inicia-se a limpeza terminal da sala, seguindo os protocolos de biossegurança. A equipe remove os resíduos, separa os materiais sujos e repõe os itens necessários para o próximo procedimento. O arsenal cirúrgico é conferido e reorganizado. A sala é preparada considerando as especificidades do próximo procedimento, garantindo que esteja pronta, segura e funcional. Todo o encerramento é conferido pela equipe técnica antes de liberar a sala.

OBS:

Documentação: Durante e após a cirurgia, são registrados todos os materiais, medicamentos, órteses, próteses e descartáveis utilizados. Esse registro é lançado nos sistemas MV em módulos específicos para controle assistencial, rastreabilidade e faturamento. Além disso, são preenchidos relatórios de intercorrências, checklists de cirurgia segura e controle de materiais críticos. Toda essa documentação serve também como respaldo para auditorias internas, externas e para a segurança do paciente.

PRINCIPAIS PROBLEMAS

- Espaço físico do bloco insuficiente para a demanda atual.
- Superlotação frequente da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).
- Atraso ou indisponibilidade de leitos na internação, causando permanência prolongada na SRPA.
- Cancelamento de cirurgias eletivas devido à sobrecarga com emergências e falta de leitos.
- Logística prejudicada pela separação física da CME e do bloco cirúrgico.
- Acúmulo de pacientes na sala cirúrgica aguardando vaga na SRPA ou leito.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO

1. **Taxa de Cancelamento de Cirurgias Eletivas:** percentual de cirurgias agendadas que são canceladas por falta de leito, superlotação ou

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO

1)
2)
3)

priorização de emergências.	4)
2. Tempo Médio de Permanência na SRPA: tempo médio que os pacientes ficam na sala de recuperação após o procedimento cirúrgico.	5)
3. Taxa de Ocupação da SRPA: percentual de ocupação da sala de recuperação, considerando sua capacidade máxima.	6)
4. % de Procedimentos Cirúrgicos Realizados dentro do Horário Previsto: cumprimento da programação cirúrgica planejada (pontualidade).	7)
5. Controle de Materiais Críticos Vencidos: percentual de materiais cirúrgicos que chegam próximos da validade e precisam ser reprocessados preventivamente	8)
1)	9)
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	

Grau de Padronização do Processo				
Durante a execução deste processo, seguimos um ciclo de etapas/atividades bem regulado/estabelecido.				
() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
Este processo é organizado de forma eficiente.				
() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
A execução deste processo é altamente padronizada.				
() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
Em grande parte, documentamos todas as ações realizadas neste processo.				
() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente